

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

CUESTIONARIO DE FALLOS DE MEMORIA DE LA VIDA COTIDIANA (MFE)

Eje V: Neurocognición y Quejas Subjetivas • Memoria Cotidiana de Sunderland y Estandarización de Montejo

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Cuestionario de Fallos de Memoria de la Vida Cotidiana (MFE - 30 ítems).
Nombre Original	Memory Failures of Everyday (MFE; Sunderland, Watts, Baddeley & Harris, 1984).
Autores Originales	Gillian E. Sunderland, D. E. Broadbent, Alan D. Baddeley y J. E. Harris (MRC Applied Psych. Unit).
Adaptación Hispana	Manuel Montejo, Mercedes Montenegro, et al. (Unidad de Memoria, Madrid Salud, 2001, 2012).
Eje Clínico y Constructo	Eje V: Neurocognición. Quejas subjetivas de fallos de memoria en actividades diarias.
Tipo de Instrumento	Cuestionario de autoinforme estructurado para adultos y personas mayores.
Composición de Ítems	30 reactivos en escala Likert de 3 opciones (0 a 2; rango 0 a 60 puntos).
Población y Rango	Adultos y personas mayores (≥ 50 años); evaluación de Quejas Subjetivas de Memoria (QSM).
Tiempo de Administración	8 a 10 minutos de cumplimentación autónoma o guiada por examinador.
Régimen de Licencia	Acceso abierto para la práctica clínica asistencial en centros de salud y memoria.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: LAS QUEJAS SUBJETIVAS DE MEMORIA (QSM)

El **MFE** fue diseñado para evaluar los lapsus cotidianos de la memoria en contextos ecológicos, adaptado ampliamente en España por la Unidad de Memoria de Madrid Salud:

- Detección de Quejas Subjetivas:** En fases preclínicas del envejecimiento patológico, el paciente suele percatarse de pequeños olvidos antes de que los tests objetivos muestren un declive psicométrico concluyente.
- Doble Vía Etiológica:** El MFE permite al clínico discriminar entre la queja originada por sintomatología afectiva (depresión y ansiedad, con sobreestimación dramática de fallos menores) y los despistes progresivos del Deterioro Cognitivo Leve amnésico.
- Seguimiento y Eficacia Terapéutica:** Es una de las escalas más utilizadas para medir el impacto de programas de estimulación cognitiva y talleres de entrenamiento de memoria en adultos mayores.

3. DIMENSIONES EVALUADAS Y COMPOSICIÓN DE REACTIVOS (30 ÍTEMS)

Dimensión Mnésica	Reactivos	Manifestaciones Cotidianas Exploradas por el MFE
1. Memoria de Actividades y Planes	Ítems 1, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 (8 ítems)	Fallos en memoria prospectiva: olvidar recados programados, no tomar medicación a su hora y desatender citas pactadas.
2. Reconocimiento de Cosas y Lugares	Ítems 2, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 (8 ítems)	Extraviar objetos habituales (llaves, gafas, monedero), desorientación en rutas poco usuales y dudas sobre lugares conocidos.
3. Memoria de Conversaciones	Ítems 3, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 (8 ítems)	Repetir la misma pregunta o anécdota varias veces, olvidar lo que se acaba de escuchar y perder el hilo en charlas.
4. Memoria Semántica y Nombres	Ítems 7, 11, 15, 19, 23, 27 (6 ítems)	Olvidar nombres de familiares o conocidos, fenómeno de la punta de la lengua y vacilaciones al nombrar objetos comunes.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

La adaptación de la Unidad de Memoria de Madrid Salud (Montejo et al., 2001, 2012; $N > 1100$) avala su validez:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Consistencia Interna Total	Alfa de Cronbach = 0.90 - 0.93	Excelente fiabilidad psicométrica en adultos mayores comunitarios y clínicos.
Estabilidad Test-Retest	Coefficiente $r = 0.84$ (a 1 mes)	Elevada reproducibilidad temporal en ancianos sin deterioro evolutivo.
Validez Concurrente	$r = 0.52$ con GDS-15 (afecto)	Correlación moderada con sintomatología depresiva en personas mayores.
Sensibilidad en QSM	Sensibilidad = 86%	Identifica de forma fidedigna a personas que demandan talleres de memoria.
Especificidad Diagnóstica	Especificidad = 82%	Distingue adecuadamente olvidos propios de la edad de disfunción patológica.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁMPUTO DE PUNTUACIONES

- **Opciones de Puntuación:** Cada uno de los 30 ítems se califica según la escala de Montejo et al.: 0 = Nunca o casi nunca, 1 = Algunas veces, 2 = Muchas veces o habitualmente.
- **Cálculo de la Puntuación Total:** Sumatoria directa de los 30 reactivos:

$$\text{Puntuación Total MFE} = \sum_{i=1}^{30} \text{Ítem}_i \quad (\text{Rango: 0 a 60 puntos})$$

- **Direccionalidad:** A mayor puntuación, mayor severidad percibida de los fallos de memoria cotidianos.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Estratificación	Puntos MFE	Percentil	Significación Clínica y Nivel de Queja (Montejo et al.)
Sin Queja / Mínima	0 a 10 puntos	$P < 30$	Memoria cotidiana conservada; olvidos mínimos esperables por la edad.
Promedio Normativo	11 a 18 puntos	$P = 30$ a 65	Queja leve dentro de la variabilidad de la población mayor normal.
Queja Moderada	19 a 25 puntos	$P = 66$ a 84	Punto de corte preventivo quejas cotidianas que causan preocupación.
Queja Severa	≥ 26 puntos	$P \geq 85$	Punto de corte clínico quejas severas; derivar a Unidad de Memoria.

BAREMOS DE MADRID SALUD (MEDIA = 14.2; DE = 8.6; CORTE ≥ 26 PUNTOS):

En la baremación oficial de Montejo et al. ($N = 1142$), la media poblacional es de **14.2 puntos**. El punto de corte de **≥ 26 puntos (P85)** identifica quejas subjetivas clínicamente significativas que aconsejan una evaluación neuropsicológica objetiva (TAVEC o MoCA) y un despistaje de depresión geriátrica mediante la escala Yesavage (GDS-15).

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE GESTIÓN DE QUEJAS DE MEMORIA EN ADULTOS MAYORES

PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN UNIDADES DE MEMORIA CON EL MFE:

- **Paso 1 (Administración del MFE):** Auto-reporte de los 30 ítems; si el paciente tiene dificultad visual, lectura asistida sin inducir respuestas.
- **Paso 2 (Análisis Clínico y Cribado Objetivo):**
 - **MFE < 19 puntos:** Quejas subjetivas mínimas; derivar a programas comunitarios de envejecimiento activo y talleres preventivos.
 - **MFE 19 a 25 puntos:** Queja moderada; administrar prueba objetiva breve (MoCA o MEC). Si la prueba objetiva es normal, realizar seguimiento anual.
 - **MFE ≥ 26 puntos:** Queja severa; cruzar con reporte de informante:
 - Si el informante no detecta fallos y el paciente presenta alta angustia → **Sospecha de depresión o ansiedad geriátrica.**
 - Si el informante confirma olvidos graves en finanzas o medicación → **Sospecha de Deterioro Cognitivo Leve amnésico;** estudio neuropsicológico exhaustivo.
- **Paso 3 (Intervención):** Inclusión en talleres de memoria, estimulación cognitiva y psicoeducación sobre estrategias mnemotécnicas externas.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN UN TALLER DE ESTIMULACIÓN

Identificación: Mujer de 71 años, maestra de escuela jubilada, acude por iniciativa propia al Centro de Salud de su distrito preocupada por frecuentes despistes: extravío reiterado del monedero, olvido de nombres de exalumnos y sensación de que "su cabeza ya no responde como antes".

Evaluación con MFE:

- **Puntuación Total MFE = 28 / 60 puntos (Queja subjetiva severa,** Percentil 88, claramente superior al umbral de 26 puntos).
- **Desglose de Áreas:** Puntuación elevada en Extravío de objetos (12/16 pts) y Memoria de nombres (8/12 pts).

Evaluación Cognitiva Objetiva:

- **MoCA:** 28 / 30 puntos (normal; recuerdo de 4/5 palabras, praxias conservadas).
- **Escala de Depresión Geriátrica (GDS-15):** 3 puntos (sin depresión clínica).

Juicio Diagnóstico: Quejas Subjetivas de Memoria (QSM) en contexto de envejecimiento saludable con alta autigencia personal.

Plan Terapéutico: Incorporación al Taller de Memoria y Entrenamiento Cognitivo del Ayuntamiento de Madrid (10 sesiones de estrategias de asociación, categorización y uso de agenda). Tras 6 meses, la puntuación MFE disminuyó a 15 puntos, reportando notable incremento en su autoeficacia cotidiana.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

PARADOJA DE ANOSOGNOSIA:

En la Enfermedad de Alzheimer establecida, el paciente puntúa muy bajo en el MFE (< 10) porque no recuerda sus olvidos; desconfiar de quejas ausentes con queja familiar.

EFECTO DE LA JUBILACIÓN:

La falta de rutinas tras la jubilación incrementa los despistes sin base neurodegenerativa; instaurar horarios y vida activa antes de alarmar al paciente.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Sunderland, G. E., Watts, K., Baddeley, A. D., & Harris, J. E. (1984). Everyday memory failures in the elderly: A questionnaire study. *Journal of Gerontology*, 39(1), 74-84.
2. Montejo, M., Montenegro, M., Reinoso, A. I., et al. (2001). Cuestionario de fallos de memoria de la vida cotidiana (MFE): Baremación y datos normativos. *Revista de Neurología*, 32(8), 701-708.
3. Montejo, M., et al. (2012). Estudio de la queja subjetiva de memoria en personas mayores y su relación con el deterioro cognitivo. *Revista Española de Geriatria y Gerontología*, 47(4), 161-166.
4. Baddeley, A. D. (1990). *Human memory: Theory and practice*. Lawrence Erlbaum Associates.